



RUMAH SAKIT
PRIMA HUSADA

**PROGRAM PENGENDALIAN
RESISTENSI ANTIMIKROBA
RS PRIMA HUSADA MALANG
TAHUN 2026**

Jl. Banjararum Selatan No. 3, Mondoroko, Singosari - Malang

Telp. 0341 - 458679, 458916, Fax. 441874

Email : sekretariat@malang.rs-primahusada.com

www.rs-primahusada.com



**PROGRAM PENGENDALIAN RESISTENSI ANTIMIKROBA
RS PRIMA HUSADA MALANG
TAHUN 2026**

**BAB I
PENDAHULUAN**

1.1 Latar Belakang

Program Pengendalian Resistensi Antimikroba (PPRA) merupakan kepanitiaan di rumah sakit yang berperan dalam menetapkan kebijakan penggunaan antibiotik, pencegahan dan penyebaran bakteri yang resisten serta pengendalian resistensi bakteri terhadap antibiotik. Pada setiap kepanitiaan tersebut, apoteker berperan penting dalam meningkatkan penggunaan antibiotik yang bijak.

Penyakit infeksi di Indonesia masih termasuk dalam sepuluh penyakit terbanyak. Kejadian peresepan antibiotik yang tinggi dapat berpotensi untuk menimbulkan penggunaan antibiotik yang tidak bijak. Penggunaan antibiotik dikatakan bijak apabila antibiotik digunakan sesuai antara penyebab infeksi dengan dosis optimal, lama pemberian optimal, efek samping minimal, dan dampak minimal terhadap munculnya mikroba resisten. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa telah muncul mikroba yang resisten antara lain *Methicillin Resistant Staphylococcus Aureus* (MRSA), resistensi multi obat pada penyakit tuberkulosis (MDR-TB) dan lain sebagainya. Dampak resistensi bakteri terhadap antibiotik adalah meningkatnya morbiditas, mortalitas dan biaya kesehatan bagi pasien.

Di rumah sakit, penggunaan antibiotik yang tidak rasional mendorong berkembangnya resistensi terhadap bakteri yang akan menyebar melalui infeksi silang. Terdapat hubungan antara penggunaan atau kesalahan penggunaan antibiotik dengan timbulnya resistensi bakteri penyebab infeksi nosokomial. Resistensi tidak dapat dihilangkan, tetapi dapat diperlambat melalui penggunaan antibiotik yang bijak dan rasional. Hal tersebut membutuhkan kebijakan dan program pengendalian antibiotik yang efektif.

Penggunaan antibiotik yang terkendali dapat mencegah munculnya resistensi antimikroba dan menghemat penggunaan antibiotik yang pada akhirnya akan mengurangi beban biaya perawatan pasien, mempersingkat lama perawatan, penghematan bagi rumah sakit serta meningkatkan kualitas pelayanan rumah sakit. Selain itu, penggunaan antibiotik yang tidak tepat oleh pasien meliputi ketidakpatuhan pada regimen terapi dan swamedikasi antibiotik dapat memicu terjadinya resistensi.

Muncul dan berkembangnya mikroba resisten dapat dikendalikan melalui dua kegiatan utama, yaitu penerapan penggunaan antibiotik secara bijak atau rasional (*prudent use of antibiotics*), dan penerapan prinsip pencegahan penyebaran mikroba resisten melalui kewaspadaan standar. Penggunaan antibiotik secara bijak ialah penggunaan antibiotik yang sesuai dengan penyebab infeksi dengan rejimen dosis optimal, lama pemberian optimal, efek samping minimal, dan dampak minimal terhadap munculnya mikroba resisten. Pengendalian penggunaan antibiotik dalam upaya mengatasi masalah resistensi antimikroba dilakukan dengan menetapkan Kebijakan Penggunaan Antibiotik di Rumah Sakit, serta menyusun dan menerapkan Panduan Penggunaan Antibiotik Profilaksis dan Terapi. Selain itu, untuk memastikan penggunaan antibiotik dilakukan dengan bijak dan bertanggung jawab, dapat dilakukan evaluasi penggunaan antibiotik

1.2 Dasar Hukum

Dalam penyelenggaraan Rumah Sakit harus berdasarkan peraturan dan undang – undang yang berlaku, diantaranya:

1. Undang undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.
3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2406/ MENKES/ PER/ XII/ 2011 tentang Pedoman Umum Penggunaan Antibiotik.



4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2015 tentang Program Pengendalian Resistensi Antimikroba di Rumah Sakit.
5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 72 tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit.
6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2021 Pedoman Penggunaan Antibiotik
7. Keputusan Direktur Perseroan Terbatas Disa Prima Medika Nomor 1042.92/DPM/I-KEP/DIR/IX/2025 tentang Pengangkatan PLT Direktur Rumah Sakit Prima Husada Malang.
8. Keputusan Direktur Rumah Sakit Prima Husada Nomor 838.1/I-KEP/DIR/IX/2025 tentang Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Rumah Sakit Prima Husada.

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Program Pengendalian Resistensi Antimikroba (PPRA) RS Prima Husada Malang Tahun 2026 disusun sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan dalam pemantauan, edukasi, tata laksana rasional dan surveilans. Dokumen ini menjadi acuan dalam memberikan pelayanan yang profesional, terstandar, dan selaras dengan visi–misi rumah sakit

1.3.2. Tujuan Umum

1. Menggunakan antibiotik secara bijak dan rasional.
2. Mencegah penyebaran mikroba resisten terhadap antibiotik.

1.3.3. Tujuan Khusus

1. Meningkatkan pemahaman tenaga kesehatan tentang penggunaan antibiotik secara bijak dan rasional.
2. Mencegah penyebaran mikroba resisten.
3. Meningkatkan pelayanan farmasi klinik dalam memantau penggunaan antibiotik.
4. Melaksanakan surveilans pola penggunaan antibiotik.
5. Melaksanakan surveilans pola mikroba dan kepekaan antibiotik.



BAB II

GAMBARAN UMUM

2.1 Visi

2.1.1 Visi Rumah Sakit

Menjadi Rumah Sakit berkualitas prima pilhan seluruh lapisan masyarakat.

2.1.2 Visi Pengendalian Resistensi Antimikroba

Melaksanakan upaya pengendalian resistensi antimikroba di lingkungan rumah sakit secara efektif dan efisien, berfokus pada keselamatan pasien.

2.2 Misi

2.2.1 Misi Rumah Sakit

1. Memberikan Pelayanan Kesehatan dengan Aman, Tepat, Cepat dan Akurat.
2. Mengutamakan Kepuasan dan Keselamatan Pasien.
3. Meningkatkan Mutu Pelayanan yang Berkelanjutan.

2.2.2 Misi Pengendalian Resistensi Antimikroba

1. Memberikan pelayanan Kesehatan yang aman, nyaman dan memuaskan.
2. Mewujudkan Sumber Daya Insan iyang loyal dan professional.
3. Memberikan pelayanan kesehatan yang paripurna, bermutu dan memuaskan serta terjangkau oleh seluruh lapisan Masyarakat.

2.3 Motto

2.3.1 Motto rumah sakit

Sahabat Menuju Sehat.

2.3.2 Motto pengendalian Resistensi Antimikroba

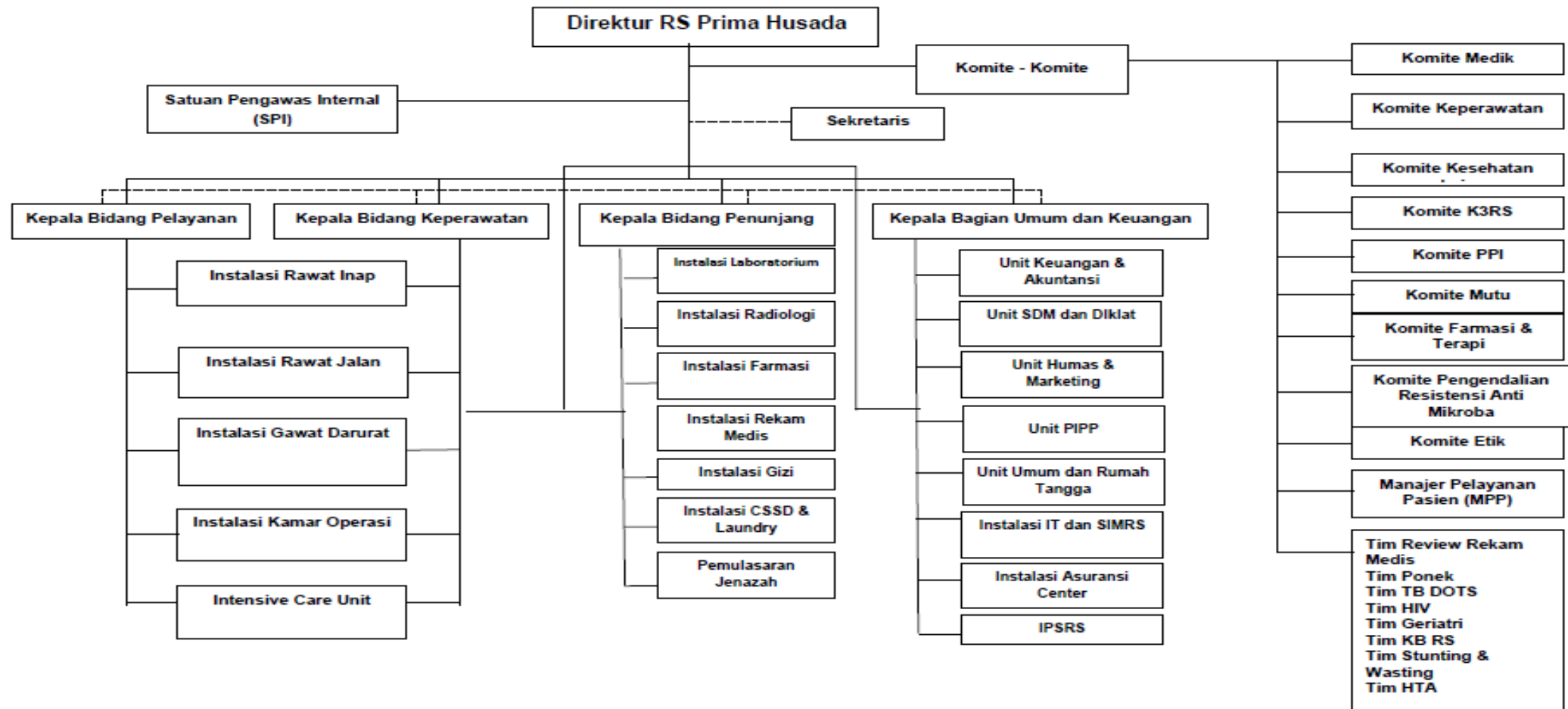
Mengendalikan penggunaan antibiotik dengan hati, berhati-hati dan tidak sesuka hati

2.4 7 Nilai Budi Utama

1. Jujur
2. Tanggungjawab
3. Visioner
4. Disiplin
5. Kerjasama
6. Adil
7. Peduli

2.5 SOTK

STRUKTUR ORGANISASI RUMAH SAKIT





SOTK KOMITE PPRA

Direktur RS. Prima Husada Malang

dr. Resti Lestantini, M. Kes



Ketua PPRA

dr. Dicky Faturrachman, Sp. A., M. Biomed



Sekretaris PPRA

apt. Risdah Bunga Kwintana, S. Farm



Dokter Spesialis

dr. Ari Putriani, Sp. PK
dr. Arief Heru Wicaksono, Sp. An
dr. Ardhi Bustami, Sp. PD
dr. Adhya Aji Pratama, Sp. PD
dr. Antonius Setiadi, Sp. B
dr. Iwan Donosepoetro, Sp. B.

FINACS

dr. Sigit Wahyu Jatmiko, Sp. BP-RE
dr. Heriyatmo, Sp. Pd
dr. Ira Setya, Sp. JP
dr. Dewi Maharani, Sp. S
dr. Titok, Sp. M
dr. Aida M., Sp. OG
dr. Andy, Sp. P
dr. Pradana Nurhadi, Sp. U
dr. Arianto, Sp. OT
dr. Miftakhul Huda, Sp. KJ
drg. Bhakti Prasetyo D, Sp. Ort
dr. Nimim, Sp. KK

Dokter

dr. Naufal Farid Dwi Rendragraha
dr. Rino R.

Apoteker

apt. Yuanita Eka L, S. Farm
apt. Pipin Purwa Ningrum, S. Farm
apt. Ajeng Janani, S. Farm
apt. Guspa Gayatri A, S. Farm
apt. Fadilah Maulana Irham A, S. Farm
apt. Diryanti Barin Putri, S. Farm

Perawat

ns. Very Susanto, S. Kep
ns. Siti Durotul Ibadiyah, S. Kep
Puput Sekar Nari Ratih, Amd. Kep
Sherly Rosita, Amd. Kep
Trikaya Inggar Yuniar, Amd. Kep

Laboratorium

Nabila Rizky Amalia, Str. Kes



2.6 Permasalahan Kinerja Tahun 2025

No	Program Kerja Tahun 2025	Permasalahan	Keterangan
1	Peningkatan pemahaman dan kesadaran penggunaan antimikroba secara bijak bagi seluruh tenaga kesehatan, staff dirumah sakit serta pasien dan keluarga	1) Kurangnya pemahaman anggota komite PPRA terkait pelaporan PPRA dengan menggunakan metode SIRS Online. 2) Belum terlaksana keikutsertaan pelatihan anggota komite PPRA secara external yang diselenggarakan oleh PRAINDO.	
2	Peningkatan Pemantauan dan Audit penggunaan antimikroba secara bijak melalui penerapan Penatagunaan Antimikroba (PGA)	1) Belum terlaksana pembuatan daftar pengelompokan daftar antibiotik terbatas berdasarkan permenkes. 2) Belum dilakukan sosialisasi hasil pengelompokan antibiotik kepada DPJP. 3) Belum berjalannya pengisian formulir permintaan antibiotik melali pop-up pada sistem informasi RS (SIMRS). 4) Pelaksanaan audit dan feedback berkala terkait pola persepan antimikroba belum lengkap dan rutin.	Masih dalam proses penyusunan
3	Surveilans penggunaan antibiotik secara kuantitatif dan kualitatif	1) Pengumpulan data surveilans masih dilakukan secara manual dari rekam medis. 2) Belum ada penambahan fitur laporan penggunaan antibiotik dengan format sesuai hasil rapat. 3) Belum terlaksana dengan baik terutama pemberian feedback kepada DPJP belum dilakukan.	
4	Survailens resistensi antimikroba dengan indikator mikroba MDRO	Kurangnya permintaan kultur oleh DPJP dikarenakan keterbatasan plafon.	
5	Indikator mutu Program Pengendalian Resistensi Antimikroba RS	Belum pernah dilakukan: 1) Telusur /pengkajian kasus melalui forum kajian kasus infeksi terintegrasi perbaikan kuantitas penggunaan antibiotic (FORRKIT) secara rutin. 2) Perbaikan kualitas penggunaan antibiotic (hasil diskusi FORRKIT). 3) Perbaikan pola kepekaan antibiotik dan penurunan pola resistensi antimikroba. 4) Penurunan angka kejadian infeksi di rumah sakit yang disebabkan oleh mikroba multiresisten. 5) Penanganan kasus infeksi secara multidisiplin, melalui FORRKIT.	



BAB III
KEGIATAN DAN RINCIAN KEGIATAN

3.1 Kegiatan Pokok dan Rincian Kegiatan

NO	KEGIATAN POKOK	RINCIAN KEGIATAN
1.	Peningkatan SDM (pemahaman terkait PPAB dan penggunaan antibiotik secara bijak dan rasional kepada seluruh tenaga kesehatan, pasien dan keluarga pasien)	1) Melakukan sosialisasi: PPAB dan terkait penggunaan antibiotik secara bijak kepada seluruh tenaga kesehatan. 2) Melakukan KIE tentang penggunaan antibiotik yang bijak kepada pasien dan keluarga pasien. 3) Mengikuti diklat eksternal.
2.	Melaksanakan penggunaan antimikroba secara bijak melalui penerapan PGA (Penatagunaan Antimikroba)	1) Membuat daftar pengelompokan antibiotik AwaRe. 2) Melakukan sosialisasi penggunaan Form PGA sebelum pemberian antibiotik tertentu. 3) Melakukan audit dan <i>feedback</i> berkala terkait pola persepsian antimikroba.
3.	Melaksanakan Surveilans penggunaan antimikroba secara kuantitatif dan kualitatif	1) Melakukan evaluasi secara kuantitatif dengan menggunakan metode DDD. 2) Melakukan evaluasi secara kualitatif dengan metode Gyssens. 3) Menyusun laporan penggunaan antibiotik (tiap triwulan dan tahunan).
4.	Melakukan Pemantauan Program Peningkatan mutu sesuai indikator mutu PPRA melalui pelaksanaan forum kajian kasus infeksi.	1) Menyelenggarakan forum kajian kasus tata laksana infeksi pengelolaan penyakit infeksi terintegrasi (FORKKIT) jika ada kasus. 2) Melakukan perbaikan kuantitas penggunaan antibiotik (hasil diskusi FORKKIT). 3) Melakukan pemantauan penurunan angka kejadian infeksi di rumah sakit yang disebabkan oleh mikroba multiresisten. 4) Melakukan pemantauan penanganan kasus infeksi secara multidisiplin, melalui FORKKIT. 5) Membuat kebijakan baru jika diperlukan.

3.2 Sasaran

NO	RINCIAN KEGIATAN	TUJUAN	SASARAN KEGIATAN	JENIS	TARGET/ STANDARD	INDIKATOR KEBERHASILAN	KET
1	Sosialisasi terkait PPAB dan penggunaan antibiotik yang bijak kepada seluruh tenaga kesehatan, staff rumah sakit, pasien dan keluarga.						
1)	Melakukan sosialisasi kepada tenaga kesehatan	1. Meningkatkan kepatuhan DPJP dalam peresepan antibiotik sesuai dengan PPAB. 2. Meningkatkan pemahaman dan ketaatan staf medis fungsional dan tenaga kesehatan dalam penggunaan antibiotik secara bijak;	1.dokter, drg 2.dokter spesialis 3.PPA, 4.nakes lain	Peningkatan SDM	100% sasaran	UMANDOK	
2)	Melakukan sosialisasi kepada pasien dan keluarga	Meningkatkan pemahaman pasien dan keluarga tentang penggunaan antibiotik yang bijak sebagai upaya pencegahan resistensi	Pasien dan keluarga pasien yang mendapat antibiotik	PKRS -PPRA	100%	Form Edukasi pada ERM terisi Bukti edukasi kelompok & massa	
2	Peningkatan mutu penggunaan antimikroba secara bijak melalui penerapan PGA (Penatagunaan Antimikroba)						
1)	Membuat daftar pengelompokan antibiotik dan daftar antibiotik hasil surveillance.	1. Membuat daftar pengelompokan AB terbatas hasil dari survailens dan berdasarkan WHO). 2. Mengajukan kepada direktur untuk dilakukan pengesahan. 3. Mengusulkan untuk masukkan ke SIMRS	Tim PPRA	Regulasi	Februari 2026	Daftar kelompok AB (terdapat dalam master SIMRS)	
2)	Melakukan sosialisasi.	1. Meningkatkan pemahaman dan ketaatan DPJP dan Nakes dalam penggunaan antibiotik secara bijak. 2. Meningkatkan pelayanan farmasi klinik dalam memantau & memandu penggunaan antibiotik.	DPJP Perawat Apoteker MPP	Peningkatan SDM	April 2026	Form PGA Umandok sosialisasi	



3)	Melakukan audit dan <i>feedback</i> berkala terkait pola persebaran antimikroba.	1. Membuat Form audit 2. Melaksanakan audit 3. Membuat Laporan audit 4. Memberikan <i>Feedback</i> ke user	DPJP Komdik	Monev	1 x triwulan	Laporan Hasil Audit	
3	Survailens penggunaan antimikroba secara kuantitatif dan kualitatif						
1)	Melakukan evaluasi secara kuantitatif dengan menggunakan metode ATC/DDD.	Memastikan kesesuaian penggunaan antibiotik dengan mengambil sampel	Pasien yang mendapatkan antibiotik	Survailens	Sampel diambil tiap bulan	Dokumen bukti Laporan	
2)	Melakukan evaluasi secara kualitatif dengan metode <i>Gyssens</i>		Pasien yang mendapatkan antibiotik	Survailens	Sampel diambil tiap bulan	Laporan (narasi, tabulasi, grafik, analisis, dan rencana tindak lanjut)	
3)	Membuat Laporan & memberikan <i>feedback</i> kepada user	1.Terevaluasinya hasil kegiatan PPRA secara berkelanjutan 2.Terciptanya integrasi antar program dan tindak lanjut oleh user	1.Data-data hasil evaluasi kualitatif dan kuantitatif 2.User	Laporan Survailens Rapat	Triwulan Tahunan 100%	Laporan triwulan Laporan tahunan Bukti laporan eksternal	
4	Peningkatan mutu penanganan tata laksana infeksi melalui pelaksanaan forum kajian kasus infeksi						
1)	Melakukan forum kajian kasus terintegrasi untuk kasus infeksi yang sulit (bila ada)	Mengkaji efektivitas antimikroba pada pasien yang mengalami perburukan kondisi klinis	Forum Kajian Kasus Terintegrasi (FORKKIT)	Mutu	Jika ada kasus 100% di kaji	Umandok	
2)	Membuat kebijakan baru jika diperlukan	Meningkatkan mutu tatalaksana infeksi	Forum Kajian Kasus Terintegrasi (FORKKIT)	Regulasi	Jika ada kasus 100% jika diperlukan	Adanya kebijakan baru	

3.3 Cara Melaksanakan Kegiatan

NO	RINCIAN KEGIATAN	CARA MELAKSANAKAN KEGIATAN	METODE	MEDIA	JADWAL	BUKTI PELAKSANAAN	KET
1	Melaksanakan Peningkatan SDM (Sosialisasi PPAB & penggunaan antibiotik yang bijak kepada seluruh tenaga kesehatan, staff rumah sakit, dan pasien / keluarga						
1)	Melakukan sosialisasi kepada Nakes	1. Menyiapkan materi sesuai sasaran 2. Membuat undangan 3. Membuat Zoom 4. Pelaksanaan Sosialisasi kepada PPA 5. Sosialisasi kepada staff rumah sakit melalui WAG, komite profesi 6. Pembuatan laporan	Daring	1. Laptop 2. <i>Power point</i> 3. Jaringan Internet 4. leaflet	1. Agustus 2026 untuk staff 2. Tiap triwulan	Bukti dokumentasi UMANDOK	
2)	Melakukan sosialisasi kepada pasien dan keluarga	Pemberian KIE pada setiap pasien yang menerima antibiotik Bukti KIE ditulis di Form KIE, Memberikan leaflet	1. Langsung 2. Tidak langsung	Langsung Medsos/WA/TV RSPH	Tiap pemberian obat antibiotik 4 kali / bulan	Form KIE Supervisi Laporan	
2	Survailens penggunaan antimikroba secara kuantitatif dan kualitatif						
1)	Melakukan evaluasi secara kuantitatif dengan menggunakan metode ATC/DDD.	a.Melakukan pengumpulan & pengolahan data yang diperlukan data meliputi : 1. Nama pasien 2. Nama DPJP 3. Diagnosa 4. LOS 5. Nama Antibotik 6. Dosis dan Regimen Antibiotik 7. Data pendukung b.Melakukan pengolahan data melalui <i>spreadsheet</i> pengumpulan data PPRA.	ATC/DDD	PC-exel E-RM dan SIMRS	Setiap bulan	- Terdapat data sampling pasien yang mendapatkan antibiotik - Data olahan	
2)	Melakukan evaluasi secara kualitatif dengan metode <i>Gyssens</i>		<i>Gyssens</i>		Setiap bulan		
3)	Membuat laporan PPRA	1. Menyusun laporan penggunaan	Laporan	Media PC /softkopi	April	1. laporan triwulan	

		antibiotik tiap triwulan. 2. Melaporkan hasil laporan penggunaan antibiotik secara internal kepada direktur untuk di sampaikan kepada DPJP pada rapat komite medik. 3. Melaporkan hasil laporan secara eksternal melalui SIRS Online. 4. Memberikan Feedback kepada user.			Juli Oktober Januari	2. Laporan tahunan 3. SIRS Online.	
3	Peningkatan mutu penggunaan antimikroba secara bijak melalui penerapan PGA (Penatagunaan Antimikroba)						
1)	Membuat daftar pengelompokan antibiotik dan daftar antibiotik hasil surveillance	1. Menentukan pengelompokan antibiotik 2. Memasukkan dalam daftar sesuai kelompoknya dan persetujuan Dir RS	Exel	PC	Februari 2026	Regulasi yang telah disahkan oleh direktur RS	
2)	Melakukan sosialisasi	1. Menyiapkan materi (PPAB, Form PGA) 2. Menyiapkan Undangan 3. Melaksanakan Sosialisasi 4. Membuat Notulen 5. Membuat laporan	DPJP	Zoom, door to door	April 2026	UMANDOK	
3)	Melakukan audit dan <i>feedback</i> berkala terkait pola persepan antimikroba.	1. Menyiapkan Form audit 2. Pelaksanan Audit Form penggunaan antibiotik 3. Pembuatan laporan hasil Audit	Form PGA	ERM-SIMRS	Mei - Des 2026	Laporan hasil Audit, bukti pemberian feedback-Umandok	
4	Peningkatan mutu penanganan tata laksana infeksi melalui pelaksanaan forum kajian kasus infeksi						
1)	Menyelenggarakan forum kajian kasus terintegrasi untuk kasus infeksi yang sulit (bila ada)	1. Membuat undangan (dokter klinis, apoteker, mikrobiologi, dan perawat 2. Melakukan diskusi kasus.	Daring	Zoom	Tiap ada kasus	Umandok	

2)	Membuat Kebijakan baru jika diperlukan	1. Merumuskan perbaikan tata laksana infeksi dari hasil FORRKIT 2. Membuat kebijakan terkait hasil diskusi Forum	Diskusi	E-RM dan SIMRS	Menyesuaikan	Umandok	
----	--	---	---------	----------------	--------------	---------	--

3.4 Jadwal Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2026

NO	RINCIAN KEGIATAN	SASARAN	BULAN												TEMPAT	PIC	SUMBER DANA	KET	
			12/25	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					12
1	Melakukan pembaharuan PPAB																		
1)	Review Pedoman Kerja PPRA	Komite PPRA		√												Ruang Komkep PHM	Ketua PPRA	PT.DPM	
2)	Merevisi PPAB	Komite PPRA		√												Ruang Komkep PHM	Ketua PPRA		
2	Melaksanakan Sosialisasi PPAB & penggunaan antibiotik yang bijak kepada seluruh tenaga kesehatan, staff rumah sakit, dan pasien / keluarga																		
1)	Melakukan sosialisasi kepada Nakes	PPAB, Form PAG,Penggunaan antibiotik bijak		√												Medsos: WAG	Komite PPRA	PT.DPM	
2)	Melakukan sosialisasi kepada pasien dan keluarga	Penggunaan antibiotik bijak		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	IRNA, ICU, NICU, IGD, IRJA	Komite PPRA	PT.DPM	
3	Peningkatan mutu penggunaan antimikroba secara bijak melalui penerapan PGA (Penatagunaan Antimikroba)																		
1)	Membuat daftar pengelompokan antibiotik dan daftar antibiotik hasil surveillance	Daftar pengelompokan antibiotik			√											Ruang Komkep PHM	Komite PPRA		
2)	Melakukan sosialisasi						√									Medsos; WAG	Komite PPRA		



3)	Melakukan audit dan <i>feedback</i> berkala terkait pola persepan antimikroba.							√	√	√	√	√	√	√	√	ICU	Komite PPRA		
4.	Survailens penggunaan antimikroba secara kuantitatif dan kualitatif																		
1.	Melakukan evaluasi secara kuantitatif dengan menggunakan metode ATC/DDD.	Pasien yang memperoleh antibiotk		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√		Komite PPRA		
2.	Melakukan evaluasi secara kualitatif dengan metode Gyssens	Pasien yang memperoleh antibiotk		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√		Komite PPRA		
3.	Membuat laporan PPRA						√			√			√			Komkep PHM	Komite PPRA		
5.	Peningkatan mutu penanganan tata laksana infeksi melalui pelaksanaan forum kajian kasus infeksi																		
1.	Menyelenggarakan forum kajian kasus terintegrasi untuk kasus infeksi yang sulit		Bila terdapat kasus													Daring melali zoom	Komite PPRA		

3.5 Kebutuhan Anggaran

Kebutuhan biaya pengembangan SDM Komite PPRA RS Prima Husada Malang Tahun 2026

N o	Kegiatan / Rincian Kegiatan	Internal Eksternal	Jumlah (Satuan)	Harga Satuan	Total Rp
2	Pelaksanaan Sosialisasi staff rumah sakit terkait PPRA	Internal	212	-	-
3	Sosialisasi dan edukasi kepada pasien dan keluarga pasien tentang : a. Penggunaan antibiotik secara bijak b. Peningkatan dan pemahaman resistensi antimikroba	Internal	-	-	-
4	Pelatihan / Workshop eksternal PRAUD PRAINDO basic	Eksternal	1	4.500.000	4.500.000



BAB IV

MONITORING DAN EVALUASI

Evaluasi program kerja komite PPRA dilakukan setiap satu bulan sekali dengan melihat pencapaian kegiatan yang dilaksanakan pada bulan sebelumnya, sehingga apabila dari evaluasi terdapat ketidaksesuaian terhadap jadwal, maka dapat dilakukan perbaikan. Untuk menunjang kegiatan tersebut, perlu dilakukan pelaporan kepada Direktur Rumah Sakit setiap tiga bulan sekali.

BAB V

PENCATATAN DAN PELAPORAN

Pencatatan dan pelaporan atas pelaksanaan kegiatan program kerja disampaikan berupa:

1. Laporan tiap 3 bulan / triwulan
Sebagai laporan internal yang merupakan rekapitulasi hasil kerja Komite Pengendalian Resistensi Antimikroba yang dilaporkan kepada Direktur Rumah Sakit setiap 3 bulan.
2. Laporan tahunan
Sebagai laporan internal yang merupakan rekapitulasi hasil kerja Komite Pengendalian Resistensi Antimikroba kepada Direktur setiap tahun.
3. Laporan tahunan
Sebagai laporan eksternal yang merupakan rekapitulasi hasil kerja Komite Pengendalian Resistensi Antimikroba kepada Tim KPRA Pusat melalui SIRS Online (<https://perizinan-yankes.kemkes.go.id/sirsonline/>).



BAB VI
PENUTUP

Demikian Program Komite Pengendalian Resistensi Antimikroba Rumah Sakit Prima Husada Malang tahun 2026 ini kami susun sebagai acuan dalam pelaksanaan pengendalian resistensi antimikroba Rumah Sakit Prima Husada Malang selama periode kerja tahun 2026. Kami menyadari dalam penyusunan program kerja ini masih banyak kekurangan sehingga diharapkan adanya kritik dan saran untuk perbaikan selanjutnya.

Malang, 02 Januari 2026

Penyusun,

Ketua Komite PPRA

dr. Dicky Faturrachman, Sp. A., M. Biomed.

Mengetahui,

PLT Direktur RS Prima Husada
Malang



dr. Resti Lestantini, M. Kes